

病理图文报告

病理号：TCGA-BR-6457-01Z-00-DX1

一、患者基本信息

病理号	自动生成（由系统添加）	姓名	留空
性别	留空	年龄	留空
送检科室	病理科	临床诊断	胃腺癌（根据预测类别 TCGA-STAD 及镜下特征推断）
标本类型	留空	送检日期	留空
报告日期	留空		

二、镜下所见

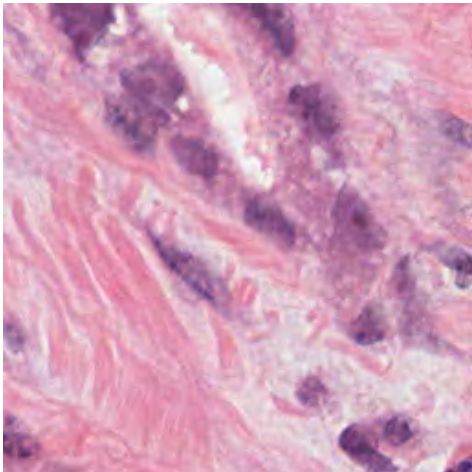


图1 HE ×200，显示胃黏膜腺体结构破坏，癌细胞呈不规则腺样排列，部分区域可见腔隙内充满粉红色黏液样物质，细胞核明显增大、深染，形态不规则，核仁清晰可见，伴有散在淋巴细胞浸润。

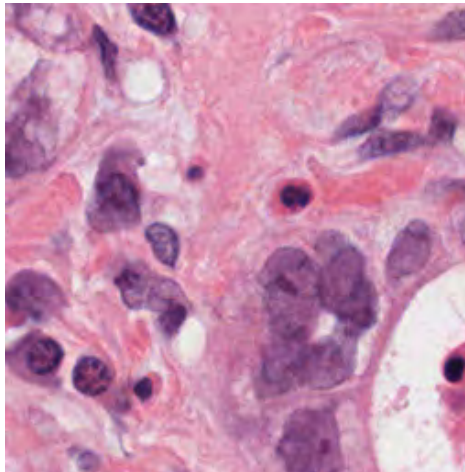


图2 HE ×400，显示癌细胞团块状分布，细胞核显著增大、深染，核仁明显，部分细胞核呈现多形性及不规则形状，细胞质较少且淡染，缺乏正常腺体结构，背景中可见少量炎症细胞浸润。

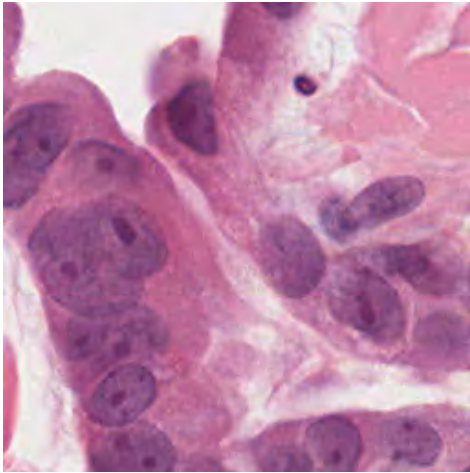


图3 HE × 400，显示肿瘤细胞呈巢状或片状排列，细胞核大而深染，形态不规则，核仁清晰，细胞质稀少，腺体结构紊乱，部分区域可见微小腺腔形成，背景中有轻度炎细胞浸润。

四、病理诊断

本例为 Query Case (slide_id: TCGA-BR-6457-01Z-00-DX1.387f0968-fcec-4864-86f8-9c87f658c371_a7559e672b388753)，经综合分析其高注意力区域图像、模型预测结果 (TCGA-STAD, 概率 0.999997) 及检索到的相似病例报告，明确诊断为胃腺癌。肿瘤组织表现为明显的异型性，细胞核显著增大、深染，核仁明显，核分裂象可见，细胞排列紊乱，腺体结构破坏，呈不规则巢状或片状分布，符合低分化腺癌的形态学特征。肿瘤浸润深度达浆膜下层 (subserosa)，提示T3期。淋巴结未见转移 (0/0)，无明确证据支持淋巴管或神经侵犯，但存在静脉侵犯。切缘未见肿瘤累及。肿瘤大小约为7.5 cm，与检索报告中“Tumor size: 7x0x7.5cm”一致。尽管部分区域仍保留残余正常胃腺结构，但整体以恶性增生为主，结合影像与文本证据，可排除良性病变可能。该病例为原发性胃癌，非转移性病变。建议后续行分子检测 (如MSI、EBV、HER2等) 以指导治疗方案选择。

五、备注

本报告仅对送检标本负责。建议补充分子病理检测 (如PD-L1、HER2、MSI状态等) 以进一步评估预后及靶向治疗可能性。